BC3 – Chapitre 5 : tout ce qu'il faut savoir

Littératie en santé – fiche complète (à jour au 1er novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 5 : définitions (Sørensen, Nutbeam, littératie alimentaire, distribuée, organisationnelle), données françaises, enjeux de santé publique, repérer sans stigmatiser, écrire clair et FALC, lisibilité, images et pictogrammes, faire dire, littératie dans le projet, étiquettes et allégations, numératie, numérique et accessibilité, allophones, tests de supports, outils pédagogiques, atelier accessible, fil rouge, cas guidés, approfondissements et méthodes d'oral. Elle suit l'ordre du cours (5.3.1 à 5.8).

Aucun fascicule du CNED ne traite la littératie : la notion est récente (référentiel 2024). Le cours s'appuie sur le guide de 2025.

Données mises à jour (à citer sous cette forme) :

- **Illectronisme** : **7 % des 16-74 ans en 2025** (10 % en 2021) et **34 % en difficulté numérique** (**Insee, enquête TIC 2025, publiée le 19 février 2026**). L'ancien chiffre de 15,4 % (15 ans ou plus, 2021) ne porte pas sur la même tranche d'âge.
- **Compétences des adultes (PIAAC 2023)** : **28 % des 16-65 ans** ont une faible maîtrise de l'écrit et **27 % du calcul** (Dares, décembre 2024). Scores France 255 (écrit) et 257 (calcul), sous la moyenne OCDE (261 et 264).
- **Journée défense et citoyenneté 2025** : **14 %** des jeunes en difficulté de lecture, dont **6 %** en très grande difficulté (DEPP, octobre 2026).
- **Illettrisme** : **7 % des 18-65 ans** scolarisés en France, ≈ **2,5 millions** de personnes, plus de la moitié en emploi (**ANLCI, enquête IVQ 2011**) : c'est toujours la dernière mesure nationale.
- **HLS19** : résultats de **2021**, derniers chiffres français ; le cycle **HLS24** recueille ses données jusqu'en juin 2026 (rapport non publié au 26 octobre 2026).
- **Nutri-Score** : algorithme révisé applicable en France depuis l'**arrêté du 14 mars 2025** (et non « depuis 2024 »), avec 2 ans de transition.
- Guide **« Communiquer pour tous »** (Santé publique France, mai 2018) : **mis à jour en février 2025**.
- **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le **8 avril 2026** : milieux de vie et réduction des inégalités sociales de santé en nutrition.

Ce qui est en **gras** est à savoir par cœur. Une référence se cite **auteur + année** et se **relie au public et à l'action**.

1. Définir la littératie en santé (5.3.1)

Littératie en santé (Sørensen et coll., 2012, consortium HLS-EU) : connaissances, **motivation** et compétences permettant d'**accéder, comprendre, évaluer et appliquer** l'information en santé, pour décider dans la vie quotidienne en matière de **soins, prévention et promotion de la santé**, tout au long de la vie. Issue d'une revue de 17 définitions et 12 modèles ; la plus utilisée en Europe.

Le modèle de Sørensen : 4 compétences × 3 domaines = 12 dimensions, mesurées par les **47 questions** du HLS-EU-Q47.

	Accéder	Comprendre	Évaluer	Appliquer
Soins (être patient)	trouver un professionnel	comprendre une prescription	juger un deuxième avis	suivre un régime prescrit
Prévention (être à risque)	trouver les repères PNNS	comprendre le Nutri-Score	juger un conseil lu sur un réseau	choisir un produit
Promotion (être citoyen)	connaître l'offre du quartier	comprendre un projet local	juger une politique	agir avec d'autres

Le modèle sert de **grille de diagnostic** (à quelle étape est la difficulté ?) et pour écrire des **objectifs**.

Les 3 niveaux de Nutbeam (2000) :

- **Fonctionnel** : lire, écrire, calculer pour comprendre une information simple (étiquette, date, dépliant). L'information « descend ».
- **Interactif (communicationnel)** : échanger, poser des questions, adapter l'information à sa situation.

- **Critique** : juger la fiabilité (publicité, réseaux, fausses informations) et **agir sur les déterminants**, seul ou en groupe (parents qui obtiennent une meilleure offre à la cantine). Plus on monte, plus on gagne en **pouvoir d'agir (empowerment)**. La promotion de la santé (Charte d'Ottawa) vise surtout ce niveau.

Historique des définitions : **Simonds 1974** (premier emploi de *health literacy*, éducation à l'école) ; **Nutbeam 1998** (glossaire OMS) ; **Institute of Medicine 2004** ; **Sørensen 2012** ; **OMS 2021** : la littératie s'acquiert aussi dans la vie quotidienne et la famille, et **dépend des organisations**.

- **Littératie organisationnelle** : capacité d'une structure à rendre l'information et les services **faciles à trouver, comprendre et utiliser** pour tous. La responsabilité est partagée : c'est aussi une qualité de l'environnement.
- **La littératie n'est pas l'intelligence ni le diplôme** : elle dépend de la personne, de la **situation** (stress, langue, fatigue, deuil) et de la complexité de l'information → on parle de **situations de littératie limitée**.
- **Ne pas confondre** : **alphabétisation** (adultes qui n'ont jamais appris à lire) ; **éducation pour la santé** (un moyen) ; **littératie** (un résultat, ce que la personne sait faire avec l'information).
- **Littératie distribuée (Edwards et coll., 2015)** : compétences réparties entre la personne et son **entourage** (enfant, voisin, aidant). Atout (aide au quotidien) et risques (erreurs, perte d'autonomie, secret) → s'adresser d'abord à la personne, faire dire, **pas d'enfant interprète**.
- **Littératie en santé mentale (Jorm et coll., 1997)** : reconnaître les troubles et savoir à qui s'adresser (TCA, chapitre 4).
- **Le diététicien agit à 2 niveaux** : développer les compétences du public **et** simplifier ce que produit sa structure.

Littératie alimentaire (Vidgen et Gallegos, 2014) : **4 domaines, 11 composantes** pour planifier, gérer, sélectionner, préparer et manger.

Domaine	Composantes (exemples d'objectifs)
Planifier et gérer	1 place dans le budget et le temps ; 2 prévoir repas et achats (liste) ; 3 choix réalistes en fin de mois
Sélectionner	4 lieux d'achat ; 5 ce que contient un aliment (ingrédients, dates) ; 6 juger la qualité
Préparer	7 faire un plat bon avec ce que l'on a ; 8 hygiène et sécurité (conserver un reste)
Manger	9 lien alimentation-bien-être ; 10 ajuster aux besoins (faim, portion) ; 11 partager les repas

Attention : la littératie alimentaire ne suffit pas quand l'**argent, le temps ou l'équipement** manquent (hôtel social sans cuisine) → agir aussi sur l'accès. Les ateliers cuisine améliorent la confiance et certains comportements (**Reicks et coll., 2014**), mais les études sont courtes et petites : **évaluer ses ateliers**.

2. Les données en France (5.3.2)

HLS19 (2019-2021, **17 pays**, réseau **M-POHL** de l'OMS Europe ; résultats France **2021**) :

- **≈ 44 %** des adultes ont une **littératie en santé limitée** : **problématique ≈ 30 %** + **insuffisante ≈ 14 %**.
- Information **numérique** : **≈ 72 %** déclarent des difficultés.
- **Gradient social** : plus bas avec les difficultés financières, un faible niveau d'études, l'âge, une mauvaise santé.
- Tâches les plus difficiles : **évaluer** (juger la fiabilité, savoir si un conseil s'applique à soi).
- Données **déclaratives** (difficulté ressentie), comparables dans le temps et entre pays.

Calcul du niveau (HLS19-Q12) : 12 questions, 4 réponses (très facile, facile, difficile, très difficile).

1. Retirer les « je ne sais pas » (réponses valides).
2. Score = réponses **faciles ou très faciles / réponses valides × 100**.
3. Classement : **> 83,3 excellent** ; **> 66,7 à 83,3 suffisant** ; **> 50 à 66,7 problématique** ; **≤ 50 insuffisant**. Problématique + insuffisant = **littératie limitée**.

Exemples : 9/12 = 75,0 (suffisant) ; **8/12 = 66,7 (problématique, sur le seuil)** ; 6 faciles sur 11 valides = 54,5 (problématique ; diviser par 12 donnerait 50,0 et classerait à tort en insuffisant) ; 5/10 = 50,0 (insuffisant).

Définitions :

- **Illettrisme** (ANLCI) : personnes **scolarisées en France** sans maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul pour être autonomes.
- **Analphabétisme** : **jamais scolarisées**.

- **Français langue étrangère (FLE)** : scolarisées dans une autre langue ; peuvent avoir une bonne littératie dans leur langue.
- **Illectronisme** : difficulté ou incapacité à utiliser le numérique (équipement ou compétences).

Règles pour utiliser ces chiffres dans un diagnostic : 1. citer **source, année, population** ; 2. **ne pas additionner** des indicateurs différents (7 % + 34 % + 44 % n'a aucun sens : mesures différentes, populations différentes, mêmes personnes comptées plusieurs fois) ; 3. ne pas appliquer un chiffre national à un quartier sans dire que c'est une estimation ; 4. compléter par des **données locales** ; 5. présenter un **besoin d'adaptation**, jamais un défaut des habitants.

3. Pourquoi la littératie compte (5.3.3)

Conséquences d'une littératie limitée (Berkman et coll., 2011, AHRQ) : moins de **prévention** (dépistages, vaccins), recours plus tardif aux soins ; plus d'**hospitalisations** et d'urgences ; moins bonne **compréhension des traitements** ; moins bonne **gestion des maladies chroniques** ; santé perçue plus mauvaise et mortalité plus élevée chez les âgés. En nutrition : étiquettes, portions, fréquences, tri des informations.

- **Littératie et inégalités sociales de santé** : déterminant **et** médiateur des inégalités. Une campagne écrite, abstraite ou numérique profite d'abord aux plus favorisés et **creuse le gradient** (« loi inverse des soins »). Réponse : **universalisme proportionné (Marmot, 2010)**.
- **Le Nutri-Score** a été conçu pour la littératie : logo synthétique, coloré, gradué, mieux compris que le tableau nutritionnel, **y compris par les moins diplômés** (équipe EREN, Hercberg et Julia).
- **Modèle de Paasche-Orlow et Wolf (2007), 3 chemins** : **accès** aux soins et à la prévention (simplifier, aller vers) ; **relation** avec les professionnels (communiquer clairement, faire dire) ; **prendre soin de soi au quotidien** (éducation pratique). Les professionnels sont sur **2 chemins sur 3** ; un projet efficace agit sur au moins deux.
- **Coût** : **106 à 238 milliards de dollars par an** aux États-Unis (**Vernon, 2007**) ; **3 à 5 %** des dépenses de santé (**Eichler, 2009**). Ordres de grandeur ; à présenter **avec l'argument de justice sociale**, jamais en faisant des personnes un « coût ».
- **Littératie et alimentation** : associations cohérentes, mais en partie dues à des **facteurs de confusion** (revenu, niveau d'études). Apprendre à lire une étiquette ne règle ni le prix ni l'offre → combiner éducation, accès, information simple.

4. Repérer sans stigmatiser (5.3.4)

Précautions universelles (AHRQ) : on ne peut pas savoir en regardant quelqu'un s'il a des difficultés ; on **applique à tous** une communication claire. Personne n'est désigné, tout le monde y gagne.

- **Signaux possibles**, à interpréter avec prudence (jamais une preuve) : « **j'ai oublié mes lunettes** », « je le lirai chez moi », formulaire rempli par un proche ; confusion grammes/kilos, 100 g/portion ; questions sur ce qui est écrit ; questionnaires non remplis ; pas d'adresse mail.
- **Questions pour adapter** : « Comment préférez-vous recevoir les informations ? » ; « Quelqu'un vous aide-t-il pour les papiers ? » ; « Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise ? » ; questionnaire de diagnostic **oral** ou en pictogrammes.
- **Outils de mesure individuelle** : **REALM (Davis, 1993)** lire des mots médicaux ; **TOFHLA (Parker, 1995)** ; **NVS (Weiss, 2005)** 6 questions sur une étiquette de crème glacée ; **question unique (Chew, 2004)** ; **HLS-EU, HLQ** (questionnaires de difficulté ressentie). Réservés à la **recherche** ou à l'**évaluation d'un programme**, avec consentement, **jamais pour trier** les participants d'un atelier (humiliant, fait fuir, ne change rien puisque tout est déjà adapté).
- **La honte (Parikh et coll., 1996)** : ≈ **4 sur 10** ont honte ; parmi eux ≈ **2/3** n'en ont jamais parlé au conjoint, **≈ 1 sur 5** à personne. **Stratégies de contournement** : venir avec un proche qui lit, mémoriser à l'oral, repérer les produits par la couleur, emporter les papiers. **Règle d'accueil** : ce n'est pas à la personne de révéler ses difficultés, c'est à la structure de rendre l'information accessible (« Ici, on remplit les papiers ensemble, c'est plus rapide »).
- **Boîte à outils AHRQ (2010)**, **4 domaines** : communication **orale** ; communication **écrite** ; **autonomie et pouvoir d'agir** ; **systèmes de soutien** (orienter vers les aides, France Services, épicerie solidaire).
- **Lancer la démarche dans une structure** : petite équipe (dont un usager) → état des lieux → 2-3 améliorations visibles → tester → former toute l'équipe (accueil, bénévoles) → suivre des indicateurs.

5. Adapter les messages et les supports (5.3.5)

Six étapes d'une communication accessible : 1. **connaître le public** (langue, écrit, numérique, culture, handicap) ; 2. **un message principal, 3 idées au plus** ; 3. **écrire simple** ; 4. **illustrer** ; 5. **tester** auprès du public ; 6. **vérifier** par le faire dire.

Règles d'écriture claire (« Communiquer pour tous ») :

Règle	À préférer
Une idée par phrase, 15 mots au plus	« Mangez du pain complet. Il contient des fibres. »
Mots courants	lentilles, pois chiches plutôt que « légumineuses » ; « choisir plus souvent » plutôt que « privilégier »
Forme active et directe	« Mangez moins de… »
Phrases positives	« Buvez de l'eau » plutôt que « ne pas oublier de boire »
Chiffres concrets	« 5 portions : une portion = un poing »
Pas de sigles	« les conseils officiels » plutôt que PNNS, AJR, IMC
Mise en page	sans empattement, **14 points** (12 au minimum), aligné à gauche, **gras** pour l'essentiel ; **pas d'italique, pas de majuscules continues, pas de texte justifié**
Image utile	photo réelle du geste ou de l'aliment, **à côté** du texte

- **Simplifier sans infantiliser** : ton adulte, vouvoiement, mot technique utile (allergène, Nutri-Score) gardé et expliqué une fois. Parler de l'**effet ressenti** (« cale plus longtemps ») plutôt que du nutriment (« fibres »).
- **Contraste et couleurs** : texte foncé sur fond clair ; pas de texte sur photo ; **jamais une information par la couleur seule**.

FALC (Facile à lire et à comprendre) : règles européennes d'**Inclusion Europe (2009)**, conçues **avec et pour les personnes en situation de handicap intellectuel**, utiles à d'autres publics. Mots simples, toujours le même mot pour la même chose, pas d'images de langage (« un petit creux »), nombres **en chiffres**, pas de pourcentages, dates en entier (« mardi 12 janvier »), une phrase par ligne. Un document n'est FALC que s'il est **relu et validé par des personnes concernées** (logo européen « Facile à lire » ; relecture par des ESAT, à rémunérer). Ressource : **SantéBD**. **Écriture claire** (pour tous, faite seul) ≠ **FALC** (méthode validée par les personnes).

Lisibilité : indice de Kandel et Moles (1958), adaptation française de Flesch (1948)

L = 207 − 1,015 × (mots / phrases) − 73,6 × (syllabes / mots)

Score	0-30	30-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
Lecture	très difficile	difficile	assez difficile	standard	assez facile	**facile**	très facile

- Pour un public à littératie limitée : viser **80 et plus**, puis **tester**.
- Exemple : 120 mots, 5 phrases, 204 syllabes → 207 − 24,36 − 125,12 = **57,5** (assez difficile) ; réécrit 96 mots, 12 phrases, 144 syllabes → 207 − 8,12 − 110,4 = **88,5** (facile).
- Les **syllabes pèsent lourd** : passer de 1,7 à 1,5 syllabe par mot fait gagner 73,6 × 0,2 = **14,7 points**.
- Compter : « l'eau » = 2 mots ; un nombre = 1 mot ; e muet final non compté ; même convention avant/après ; passage d'au moins 100 mots.
- **Flesch anglais** (206,835 − 1,015 × M/P − **84,6** × S/M) **sous-estime** un texte français d'environ **15 à 20 points** : toujours la formule de la langue. Autres : **Gunning Fog (1952)**, **Scolarius** (Québec).
- **Limite** : l'indice ne mesure ni le sens, ni les sigles, ni les images, ni la mise en page. Ne jamais coller de données personnelles dans un outil en ligne (RGPD).

Images et pictogrammes :

- **Houts et coll. (2006)** : des images bien choisies, **à côté du texte**, améliorent attention, compréhension, mémorisation et application, surtout en littératie limitée.
- Image qui aide : photo réelle du geste, portion à côté d'une main, même pictogramme pour la même idée, **montrer ce qu'il faut faire**, personnes diverses. Image qui trompe : dessin humoristique, assiette sans repère de taille, geste « interdit » (souvent retenu), corps idéalisés ou stigmatisants.
- **Un pictogramme n'est pas universel** (croix rouge = interdit ou soins) ; la norme **ISO 9186** prévoit de tester. Règle du cours : validé si **au moins 2 personnes sur 3 (66,7 %)** le comprennent (ex. lait 14/15 = 93,3 % validé ; gluten 8/15 = 53,3 % non validé → ajouter le mot et des exemples).

6. Vérifier la compréhension : le faire dire (5.3.6)

Boucle du faire dire (teach-back) : 1. **expliquer** un message à la fois ; 2. **faire dire** (« Pour être sûr(e) d'avoir bien expliqué… ») ; 3. **vérifier** ; 4. **réexpliquer autrement** si besoin (pas mot pour mot) ; 5. **confirmer**, valoriser, laisser un support. **Fiche-outil HAS 2015**.

- Ne jamais demander **« Vous avez compris ? »** (réponse « oui » par politesse ou gêne). Le faire dire teste la **clarté du professionnel**, pas la mémoire de la personne.
- **3 formes** : **découper et vérifier** (*chunk and check*, une information à la fois) ; **faire faire** (*show me* : montrer le geste, quantités, prix, public allophone) ; **faire dire à distance** (téléphone).
- **Les 3 questions clés (Ask Me 3)** : « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? » ; « Qu'est-ce que je dois faire ? » ; « Pourquoi est-ce important pour moi ? » (littératie interactive).
- **Preuves** : **Schillinger 2003** (diabétiques : vérification rare ; quand elle a lieu, meilleur équilibre, étude d'observation) ; **Ha Dinh 2016** (revue : meilleure compréhension, observance, autogestion ; effets moins nets sur les hospitalisations). Méthode **simple, peu coûteuse, sans effet indésirable**, présentée comme une bonne pratique.

7. Intégrer la littératie à chaque étape du projet (5.3.7)

Étape	Prise en compte
Diagnostic	recueillir langue, lecture, numérique ; questionnaire **oral ou imagé** ; entretiens
Objectifs	objectifs de **compétences** (« savoir lire le Nutri-Score »)
Supports	écriture claire, FALC, pictogrammes ; **tester avant diffusion**
Animation	méthodes actives, démonstration, faire dire, binômes
Communication	plusieurs canaux ; **jamais tout en numérique**
Évaluation	outils accessibles (smileys, gommettes, entretien oral) ; indicateurs de compréhension

- **Objectifs de littératie** : verbe d'action, vérifiable. Accéder (trouver, repérer, demander) ; comprendre (**expliquer, reformuler, montrer**) ; évaluer (comparer, choisir) ; appliquer (préparer, cuisiner). « Connaître » et « comprendre » seuls sont trop vagues.
- **Concevoir avec les personnes** : relecture et test ; groupe de travail ; co-animation (habitante relais) ; comité d'usagers. Reconnaître leur travail, ne pas toujours solliciter les mêmes.
- **Modèle de Nielsen (2000)** : part des problèmes repérés = **$1 - (1 - 0{,}31)^n$** → 1 testeur 31 % ; 3 testeurs **67 %** ; **5 testeurs 84 %** ; 8 testeurs 95 %. Mieux vaut **deux petits tests successifs** (5, correction, 5) qu'un grand.

8. Lire une étiquette (5.3.8)

- **Règlement INCO (UE n° 1169/2011)** : dénomination, **ingrédients par ordre décroissant de poids**, **14 allergènes mis en évidence** (gras, souligné), quantité, dates, conservation, déclaration nutritionnelle (énergie, matières grasses, AGS, glucides, sucres, protéines, sel) pour **100 g ou 100 mL**.
- **Lire en 6 étapes** : dénomination (« saveur… » = peu de l'ingrédient) ; ingrédients ; Nutri-Score ; tableau (100 g pour comparer, portion pour ce que l'on mange) ; dates (DLC ≠ DDM) ; **prix au kilo**.
- **Nutri-Score** : équipe de **Serge Hercberg** ; **arrêté du 31 octobre 2017** (logo **facultatif**) ; aussi en Belgique, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse. Calcul pour 100 g : **points défavorables** (énergie, sucres, AGS, sel) − **points favorables** (fibres, protéines, fruits-légumes-légumineuses) → lettre A à E. **Algorithme révisé** (aliments 2022, boissons 2023 ; **France : arrêté du 14 mars 2025**) : sucre et sel plus pénalisés, céréales complètes mieux classées, huiles d'olive, colza, noix en B possible, viande rouge moins bien classée, **seule l'eau obtient A** chez les boissons, édulcorants pénalisés. **Comparer dans une même famille** (deux céréales), pas une pizza et une pomme.
- **Sucres en morceaux** : g pour 100 mL × volume / 100 ; **1 morceau ≈ 5 g**. Ex. 9,8 g/100 mL × 330 mL = **32,3 g ≈ 6,5 morceaux** = 64,6 % des 50 g. **OMS** : sucres libres **< 10 % de l'énergie** (idéalement < 5 %) ≈ **50 g pour 2 000 kcal**.
- **Comparer** : céréales A (4,5 g sucres, 3,20 €/kg) et B (26 g, 4,90 €/kg) pour 40 g : 1,8 g vs 10,4 g de sucres ; **0,13 € vs 0,20 €** → « mieux et moins cher ».
- **Allégations (règlement CE n° 1924/2006)** :

Allégation	Seuil
Faible teneur en sucres	**≤ 5 g/100 g** (2,5 g/100 mL)
Sans sucres	≤ 0,5 g/100 g ou 100 mL
Sans sucres ajoutés	aucun sucre ajouté (les sucres naturels restent)
Faible teneur en matières grasses	≤ 3 g/100 g (1,5 g/100 mL)
Pauvre en sel	≤ 0,12 g de sodium/100 g (≈ 0,3 g de sel)
Source de fibres	**≥ 3 g/100 g ou 1,5 g/100 kcal**
Riche en fibres	**≥ 6 g/100 g ou 3 g/100 kcal**
Source / riche en protéines	**≥ 12 % / ≥ 20 % de l'énergie**
Allégé, réduit en…	**≥ 30 % de moins** (25 % pour le sel)

Une allégation ne fait pas un aliment favorable : « allégé en gras » peut être sucré ; « source de fibres » sur des biscuits très sucrés. Vérifier avec le tableau et le Nutri-Score.

- **Apports de référence (INCO, annexe XIII)** : énergie **2 000 kcal (8 400 kJ)** ; lipides 70 g ; AGS 20 g ; glucides 260 g ; **sucres 90 g** (tous les sucres, ≠ 50 g de sucres libres de l'OMS) ; protéines 50 g ; **sel 6 g**. La portion indiquée est souvent petite (sachet de chips de 150 g = 5 portions).

9. Numératie (5.3.9)

Numératie : capacité à comprendre et utiliser **nombres, pourcentages, proportions, probabilités** dans la vie courante.

- **Fréquences naturelles** (« 6 personnes sur 100 ») mieux comprises que les pourcentages (**Gigerenzer**). **Tableaux d'icônes** (100 icônes en lignes de 10).
- **Réduction absolue et relative** : de 6 à 4 sur 100 = **−2 points** (absolu) = **−33 %** (relatif). Le relatif seul **exagère** : donner les deux.
- **Pièges** : kJ et kcal (**1 kcal = 4,184 kJ**) ; **33 cL = 330 mL** ; comparer 100 g avec 100 g ; **points ≠ pourcentage** (10 % → 8 % = −2 points, −20 %) ; « deux fois moins » = divisé par 2 ; « **jusqu'à** 30 % » = maximum ; une moyenne cache des écarts.
- **Présenter un chiffre** : est-il indispensable ? nombres entiers, une unité connue, comparaison familière, test.
- **Mesures ménagères** : cuillère à café 5 mL ; cuillère à soupe 15 mL ; verre 150-200 mL ; bol 300-350 mL ; **poing ≈ portion de fruits ou légumes (80-100 g)** ; paume ≈ portion de viande. **Construire sa table** : 3 pesées de l'ustensile du public, moyenne (ex. verre de riz 166 g → « 1 verre pour 3 personnes »).
- **Graphiques honnêtes** : **axe à zéro** (42 % vs 46 % paraît « 3 fois plus » avec un axe à 40), un message par graphique, pas de 3D, camembert ≤ 4 parts, mêmes dénominateurs, étiquettes sur les barres, couleurs lisibles en noir et blanc.

10. Numérique et inclusion (5.3.10)

- **Évaluer une application ou un site** : éditeur et financement ; fondement scientifique ; mise à jour ; **protection des données (RGPD)** ; accessibilité ; effets indésirables (culpabilisation, obsession du comptage).
- **RGAA**, fondé sur les **WCAG** : contraste, taille de texte modifiable, **texte alternatif** des images, **vidéos sous-titrées**, liens explicites, navigation simple. Mini-audit 7/12 = 58 % → 3 corrections rapides → 10/12 = 83 %.
- **Ratio de contraste** = (luminance claire + 0,05) / (luminance foncée + 0,05), de 1 à 21. **Niveau AA : ≥ 4,5 texte courant, ≥ 3 grand texte** ; AAA : 7 et 4,5. Vert foncé sur blanc 5,13 (conforme) ; jaune sur blanc 1,41 (illisible) ; noir sur jaune 14,9.
- **Daltonisme** : ≈ **8 % des hommes, 0,5 % des femmes** (origine européenne) → doubler la couleur par un mot ou un pictogramme (comme les lettres du Nutri-Score).
- **Fausses informations** : **infodémie (OMS, 2020)**. **Sandwich de vérité** : 1. le **fait juste** ; 2. l'idée fausse **nommée une fois** comme fausse ; 3. **pourquoi elle circule** ; 4. le fait juste redit avec une **action**. Ne pas répéter l'idée fausse dans un titre (« Les conserves, un poison ? »).
- **Dispositifs d'inclusion numérique** : **France Services** ; **conseillers numériques (2021)** ; **Aidants Connect** (démarche en ligne pour le compte d'une personne, sécurisée, sans donner ses identifiants) ; médiathèques. **Mon espace santé** ouvert à tous en **2022**.

- **Règles** : toujours un **canal non numérique équivalent** ; formats peu exigeants (message vocal, vidéo sous-titrée) ; ne jamais exiger un compte ou un mail pour participer ; évaluer l'usage réel.

11. Communiquer avec des personnes allophones (5.3.11)

- **Allophone** : langue maternelle différente de celle du pays.
- **Ressources** : **interprétariat professionnel** (sur place ou par téléphone ; **référentiel HAS 2017**) ; médiateurs, habitants relais ; supports multilingues testés ; pictogrammes ; démonstration ; cours de français à visée sociale.
- **Pas d'enfant interprète** : inverse les rôles, expose l'enfant, erreurs de traduction.
- **Avec un interprète** : avant (réserver, présenter l'objectif et les mots techniques, **prévoir le double de temps**) ; début (présenter son rôle, confidentialité) ; **pendant : regarder et parler à la personne, à la première personne** (« Qu'est-ce que vous mangez le matin ? », pas « Demandez-lui… »), phrases courtes, pas d'expressions imagées (« y aller mollo sur le gras »), faire dire ; après (bilan).
- **Interprète** (traduit, neutre) ≠ **médiateur** (lien, codes, accès aux droits) ≠ **proche** (peut filtrer) : information médicale importante → interprète professionnel.
- **Ressources** : livret de santé bilingue (Comede, Santé publique France), supports PNNS, SantéBD, banques de pictogrammes.
- **Faire traduire** : simplifier d'abord en français ; traducteur professionnel (l'outil automatique = brouillon) ; relecture par des locuteurs ; vérifier les images ; tester ; dater.
- **Choisir les langues** : ex. 72 familles sur 90 parlent une autre langue (80 %) ; arabe, turc et tamoul = 75 % d'entre elles → traduire dans ces 3 langues, images et interprétariat pour les autres.
- **Adapter selon la situation** : déficience **visuelle** (oral, gros caractères, audio, repères tactiles, décrire les gestes) ; **auditive** (LSF ou LfPC, visage éclairé, consignes écrites, boucle magnétique) ; **intellectuelle** (FALC, une étape à la fois, routines) ; **motrice** (plan de travail adapté) ; **psychique** (cadre rassurant, petit groupe, pauses).

12. Tester un support, choisir des outils, animer (5.3.12 à 5.3.14)

- **Exemple complet** (fiche « Bien conserver les aliments ») : indice **30,5 → 93,0** ; compréhension testée sur 8 bénéficiaires : rangement de la viande **37,5 % → 87,5 %** ; yaourt après DLC **25 % → 75 %**. L'indice confirme ; **c'est le test qui prouve**.
- **Entretien cognitif (Willis, 2005)** : **5 à 8 personnes**, « on teste le document, pas vous » ; **penser à voix haute** ; questions de relance (« Que veut dire ce mot pour vous ? ») ; **tâche pratique** ; tableau de synthèse. On corrige **tout ce qui empêche de comprendre ou d'agir**, même signalé par une seule personne. Il dit si le support est compris, pas s'il changera les pratiques.
- **Outils pédagogiques** : objets réels, photos, **photolangage**, maquettes de portions, jeux, vidéos, supports à emporter ; **pédagothèques des IREPS**. **Analyser un outil en 8 questions** : concepteur et sources ; exactitude et date ; objectifs ; public ; participation ; non-stigmatisation ; accessibilité ; adaptations.
- **Jeu « le panier à 10 € »** : cartes-aliments avec prix par portion (lentilles 0,16 € ; œuf 0,28 € ; poulet 0,75 €) ; déjeuner pour 4 = 3,88 €, soit **0,97 € par personne**.
- **Photolangage** (Lyon, fin des années 1960) : question ouverte ; 30 à 50 photos variées ; **choix silencieux** ; **tour de parole** sans jugement ; synthèse. Droit de ne pas parler ; ce qui est dit reste dans le groupe.
- **Séquence type de 2 h** : accueil (10 min) ; photolangage (10) ; **un seul message** avec objets réels (15) ; démonstration (15) ; pratique en **binômes mixtes** avec recette en photos (40) ; dégustation et smileys (15) ; **faire dire** (10) ; clôture, fiche en photos, message vocal la veille (5).
- **Adapter** : enfants (1 h, une tâche par enfant, échelle à 3 visages) ; adolescents (partir de leurs pratiques, défis, téléphone, pas de morale) ; âgés (rythme lent, lumière, audition) ; handicap intellectuel (séance courte et régulière, routines) ; allophones (démonstration d'abord).

13. Fil rouge et cas guidés (5.3.15 et 5.3.16)

Centre social des Tilleuls (Inès) :

- Diagnostic : **11/48 (22,9 %)** parents ont demandé une lecture orale ; **6/48 (12,5 %)** parlaient peu le français → passation **orale** avec une médiatrice (arabe, soninké). Ce ne sont **pas des taux d'illettrisme**.
- Fiche « lentilles corail » : indice **54 → 82** ; testée par 3 mamans ; livret de 12 fiches, indice moyen **84** ; 4 mots corrigés (émincer, blanchir, réserver, assaisonner).

- **Tour de faire dire** à chaque atelier ; invitation papier, **message vocal WhatsApp**, mamans relais ; aucune inscription seulement en ligne ; évaluation à smileys.
- Atelier étiquettes : sucre d'une bouteille de 33 cL trouvé par **2/11 (18,2 %) avant → 9/11 (81,8 %) après**. « 5 portions = 5 poings » ; calendrier illustré des légumes secs.

Six cas guidés : affiche du plat végétarien au restaurant universitaire (indice 48,5 → 93,5 ; connaissance 34,2 → 60 % ; ventes 12,4 → 17,2 %, sans groupe témoin) ; **courrier aux parents** après le bilan de santé (jargon « 97e percentile », lettre dans le cartable : éthique) ; application des menus (contraste 3,45 < 4,5 ; 23,8 % des parents d'allergiques ne trouvent pas l'info) ; **boissons énergisantes** au club de foot (canette 250 mL : 27,5 g de sucres, 80 mg de caféine ; 2 canettes = 160 mg > 150 mg pour 50 kg, valeur EFSA 2015 de 3 mg/kg ; ANSES 2013) ; chantier d'insertion (tortilla 0,52 € la portion) ; aides à domicile formées au faire dire (vérification 10,4 → 60,4 % ; compréhension 37,5 → 70,8 %).

Expliquer un percentile en fréquences naturelles : « Sur 100 enfants du même âge et du même sexe rangés du plus mince au plus fort, votre enfant fait partie des 3 plus forts. »

14. Approfondissements (5.4 et 5.5)

- **Littératie numérique en santé (Norman et Skinner, 2006)** : 6 littératies (traditionnelle, santé, informationnelle, scientifique, médiatique, informatique). **eHEALS** : **8 affirmations notées 1 à 5, score 8 à 40**, déclaratif, sans seuil officiel ; pour comparer un groupe avant/après.
- **Juger une information en ligne : 6 questions** : qui est l'auteur ? informer ou vendre ? quelles sources ? quelle date ? cohérent avec les repères officiels ? promesses miraculeuses ?
- **Médiation en santé** : loi de modernisation du système de santé **2016** (**art. L. 1110-13 CSP**), **référentiel HAS 2017** ; **Programme national de médiation sanitaire (2011)** en habitat précaire. **Médiateur** (lien, droits) / **interprète** (traduit, ne conseille pas) / **habitant relais** (mobilise, ne traduit pas d'informations médicales).
- **Organisation « amie de la littératie » (Brach et coll., 2012)** : **10 caractéristiques** (direction engagée ; planification et évaluation ; personnel formé ; **public associé** ; niveaux variés sans stigmatiser ; oral clair et vérifié ; orientation facile ; documents faciles ; situations à risque ; **coûts expliqués**). **Audit** : 0, 1 ou 2 par caractéristique, **total sur 20** (ex. 11/20 = 55 %), priorités sur les 0. Complément L3 : **health literacy responsiveness (Trezona, 2017)**.
- **Former une équipe** : ex. 14 agents, quiz 5,1 → 7,9 sur 10 ; coût 368 € (26,29 €/participant). Évaluer aussi la **pratique**, pas seulement le quiz.
- **IA générative** : utile pour simplifier, mais erreurs typiques : **chiffre modifié, nuance supprimée, conseil inventé, source inventée, ton infantilisant**. Méthode : texte source validé **sans données personnelles** ; consigne précise ; comparaison phrase par phrase ; vérification aux sources officielles datées ; test auprès du public (FALC : relecture obligatoire). Compétence **C3.3** (enjeux de l'IA). Repères corrects à retenir : jus de fruits **un petit verre par jour au plus** ; légumes secs **au moins 2 fois par semaine** ; charcuterie **≤ 150 g par semaine** (SpF 2019).
- **École** : **parcours éducatif de santé (circulaire du 28 janvier 2016)**, 3 axes (éducation, prévention, protection). Maternelle : nommer, trier ; élémentaire : sucre sur l'emballage ; collège : tableau, portion, publicité ; lycée : fiabilité en ligne. Ne jamais commenter un goûter devant la classe (**conflit de loyauté**).
- **L3** : instruments (HLS-EU-Q47, Q16, Q12 ; **NVS** ; **HLQ, Osborne 2013**, 9 dimensions, démarche Ophelia) ; **Nutbeam 2008** : littératie **facteur de risque** vs **atout** (lien Paulo Freire, 1968) ; **Gigerenzer** : test positif, 9/108 = **8,3 %** seulement de vrais malades ; **Déclaration de Shanghai (OMS, 2016)** : littératie = 1 des 3 piliers ; *Health literacy: the solid facts* (OMS Europe, 2013).

15. Préparer l'épreuve (5.6)

- **Situations** : BC1 plan alimentaire réduit à 3 messages + faire dire ; BC2 menus et **14 allergènes** en pictogrammes testés ; BC3 atelier étiquettes à l'épicerie solidaire, campagne municipale testée avec version FALC, campagne « sucres cachés » en morceaux.
- **Méthode 1, oral en 2 minutes** : **constat** (source datée) → **choix** (2-3 adaptations reliées au constat) → **vérification** (test, faire dire, indice) → **limite** et amélioration.
- **Phrases à éviter** : « mon public avait un faible niveau » ; « j'ai testé leur niveau de lecture » ; « le support était adapté » sans preuve ; « j'ai traduit avec Google Traduction ».
- **Méthode 2, analyser un support en 5 critères** : **public et objectif** ; **texte** (phrases, sigles, négations, indice) ; **mise en page** (taille, contraste, hiérarchie) ; **images et chiffres** ; **accès et action** (canal non numérique, coût, lieu). Pour chaque critère : constat + amélioration, puis test de la nouvelle version.

- **Méthode 4, liens** : chapitre 2 (inégalités, universalisme proportionné) ; 3 (honte, stigmatisation) ; 4 (stratégies des ménages modestes) ; 6 (éthique, interprétariat, secret) ; 7 à 9 (projet) ; 10 (atelier) ; 14-15 (communication) ; 16 (risques) ; 19 (veille) ; 20 (numérique, RGPD).

16. Fiches-outils du chapitre

Outil	Contenu	Utilité
O5.1	Grille de vérification d'un support écrit (titre, 1 message, 15 mots, pas de sigle, forme active, chiffres concrets, images, police ≥ 14, contraste, infos pratiques, accès non numérique, source et date, testé)	Avant impression
O5.2	Calcul de l'indice de lisibilité, version 1 et 2	Comparer deux versions
O5.3	Audit « littératie » d'une structure	Proposer des améliorations à un partenaire
O5.4	Guide du faire dire (annoncer, expliquer, faire dire, si incomplet « je me suis peut-être mal exprimé(e) », confirmer, en groupe)	Entretien et atelier
O5.5	Test d'un support auprès du public (« Que vous dit ce document ? », « Qu'allez-vous faire ? », mots non compris)	Avis de 5 à 8 personnes

17. Chiffres et dates à savoir

Repère	Valeur
Sørensen	**2012** : 4 compétences × 3 domaines = **12 dimensions**
Nutbeam	**2000** : fonctionnel, interactif, critique
Littératie alimentaire	**Vidgen et Gallegos 2014** : 4 domaines, 11 composantes
HLS19 France	**2021** : **44 %** limitée (30 % + 14 %) ; 72 % en numérique
Seuils HLS19-Q12	> 83,3 / > 66,7 / > 50 / ≤ 50
Illettrisme	**7 %** des 18-65 ans (IVQ 2011), 2,5 millions
Illectronisme	**7 %** des 16-74 ans en 2025 ; 34 % en difficulté (Insee 2026)
PIAAC 2023	**28 %** faible écrit, 27 % faible calcul
JDC 2025	14 % en difficulté de lecture, 6 % très grande difficulté
Kandel et Moles	**1958** : L = 207 − 1,015 × M/P − 73,6 × S/M ; viser ≥ 80
FALC	Inclusion Europe **2009**
Faire dire	fiche HAS **2015**
Nielsen	5 testeurs ≈ **84 %** des problèmes
INCO	règlement **1169/2011** ; **14 allergènes**
Allégations	règlement **1924/2006**
Nutri-Score	arrêté **31 octobre 2017** ; révision : arrêté **14 mars 2025**
OMS sucres libres	< 10 % de l'énergie ≈ **50 g**
Contraste AA	**4,5** (texte courant), 3 (grand texte)
Interprétariat, médiation	référentiels **HAS 2017** ; médiation : loi **2016**
eHEALS	8 items, score **8 à 40**
Brach	**2012**, 10 caractéristiques, audit sur 20

18. Les pièges

- Croire que la littératie, c'est **savoir lire** ou que le diplôme suffit.
- **Tester** le niveau de lecture des participants, faire des groupes de niveau.
- **Additionner** illettrisme, illectronisme et littératie limitée ; appliquer un chiffre national au quartier sans le dire.
- Demander « **Vous avez compris ?** ».
- Croire qu'un **indice élevé = texte difficile** (c'est l'inverse) ; croire que l'indice **suffit** sans test.
- Appliquer la **formule anglaise** de Flesch à un texte français.
- Écrire en **majuscules**, en italique, justifié, en gris clair ; donner une information **par la couleur seule**.
- Appeler « FALC » un texte **non validé** par des personnes concernées.
- Faire traduire par un **enfant** ; parler à l'interprète au lieu de la personne ; imprimer une **traduction automatique** non relue.
- Réserver l'inscription au **numérique** ; remplir une démarche avec les identifiants de la personne.
- Présenter une **réduction relative seule** ; confondre **points et pourcentage** ; axe de graphique tronqué.
- Comparer le Nutri-Score de deux familles différentes ; croire qu'une **allégation** fait un bon aliment ; confondre AR sucres (90 g) et repère OMS (50 g de sucres libres).
- Diffuser un texte simplifié par une **IA** sans vérification phrase par phrase.
- Dire « mon public avait un faible niveau ».